

Jak pracować z formularzami monitorowania

Instrukcja używania formularzy do obserwacji sytuacji, szukania wzorców
i planowania wsparcia bez oceniania i przypisywania winy.

Spis treści

Po co są formularze	2
Zasady opisu sytuacji	2
1. Opisuj fakty obserwowalne	2
2. Oddziel tło od wyzwalacza	2
3. Zapisuj pierwsze sygnały	3
4. Notuj reakcję otoczenia	3
5. Oddziel uspokojenie od gotowości	3
Formularz prosty	4
Jak go wypełniać	4
Formularz rozszerzony	5
Sekcje formularza	5
Jak używać danych z formularzy	6
Na co zwracać uwagę	6
Czego formularz nie zakłada	6
Czego formularz nie robi	7
Nie diagnozuje	7
Nie służy do oceniania	7
Nie zastępuje oceny klinicznej	7
Nie daje jednej odpowiedzi	7
Podstawa merytoryczna	8

Po co są formularze

Formularze pomagają zamienić pojedyncze „incydenty” w dane, które można porównywać między sytuacjami.

Ich celem nie jest ocenianie osoby ani szukanie winy. Mają pomóc odpowiedzieć na pytania:

- co wydarzyło się przed wzrostem napięcia,
- jakie sygnały pojawiły się wcześniej,
- co pomogło,
- co zwiększyło trudność,
- jakie wzorce powtarzają się w czasie.

Formularz pomaga oddzielić:

- opis sytuacji od interpretacji,
- zachowanie od intencji,
- uspokojenie od powrotu do regulacji,
- pojedynczy wyzwalacz od całego kontekstu dnia.

Dzięki kilku podobnym zapisom można zauważyć wzorce, których nie widać po jednej sytuacji:

- konkretne pory dnia,
- typy wymagań,
- zmiany planu,
- warunki przeciążające,
- brak przewidywalności,
- zbyt szybkie przejścia między aktywnościami,
- długi czas potrzebny na powrót do regulacji i gotowości.

Formularz nie służy do budowania „listy problemowych zachowań”. Ma pomagać w planowaniu wsparcia i modyfikacji środowiska.

Zasady opisu sytuacji

1. Opisuj fakty obserwowalne

Zapisuj to, co można było zobaczyć lub usłyszeć.

Dobrze:

- „zacisnął dłonie”,
- „powtarzała: nie chcę”,
- „usiadł pod stołem”,
- „podniósł głos”,
- „wyszedł z sali”.

Unikaj:

- „manipulował”,
- „robił specjalnie”,
- „testował granice”,
- „był leniwy”,
- „chciała zwrócić uwagę”.

2. Oddziel tło od wyzwalacza

Wyzwalacz to nie zawsze „duża” sytuacja.

Często jest ostatnim elementem po serii wcześniejszych obciążeń: hałasie, zmęczeniu, zmianach planu, bólu, presji albo wielu drobnych wymaganiach.

3. Zapisuj pierwsze sygnały

Najważniejsze są momenty przed eskalacją.

To mogą być:

- wycofanie,
- milczenie,
- szybsze mówienie,
- napięcie ciała,
- żarty lub ironia,
- zwiększona potrzeba kontroli,
- zatrzymanie aktywności,
- „zamrożenie”.

4. Notuj reakcję otoczenia

Ważne jest nie tylko to, co zrobiła osoba, ale też:

- jak odpowiedziało otoczenie,
- czy wsparcie było dostępne,
- czy pojawiły się dodatkowe wymagania,
- czy osoba miała możliwość wyboru lub przerwy.

5. Oddziel uspokojenie od gotowości

To, że osoba przestała płakać, krzyczeć albo protestować, nie zawsze oznacza gotowość do:

- rozmowy,
- kolejnych poleceń,
- powrotu do aktywności,
- podejmowania decyzji.

W formularzu warto zaznaczyć:

- kiedy zachowanie się zatrzymało,
- a kiedy wróciła możliwość kontaktu i współpracy.

Praktycznie: jeśli po sytuacji nie wiadomo, co wpisać, zacznij od trzech rzeczy:

- co było wcześniej,
- co było pierwszym sygnałem,
- co realnie pomogło.

Formularz prosty

Formularz prosty służy do szybkiego zapisu po sytuacji.

Najlepiej sprawdza się:

- w domu,
- w szkole,
- podczas codziennych sytuacji,
- wtedy, gdy nie ma czasu na pełną analizę.

Jak go wypełniać

Pytanie	Co wpisywać	Czego unikać
1. Stan przed sytuacją	Sen, głód, ból, hałas, zmiany planu, wcześniejsze trudności.	„Miał zły humor”.
2. Pierwsze sygnały	To, co pojawiło się przed eskalacją.	„Nagle wybuchł bez powodu”.
3. Zachowanie	Fakty obserwowalne: słowa, ruchy, działania.	Interpretowania intencji.
4. Reakcja otoczenia	Co zrobiły osoby dorosłe lub otoczenie.	Pomijania wpływu środowiska.
5. Co pomogło	Co zmniejszyło napięcie lub ułatwiło powrót do regulacji.	Ogólników typu „uspokoił się”.
6. Powrót do gotowości	Ile czasu trwał powrót do kontaktu i aktywności.	Zakładania, że brak protestu = gotowość.

Formularz prosty nie ma dawać pełnej diagnozy sytuacji.
Ma umożliwić szybki zapis danych, które później można porównać.

Formularz rozszerzony

Wersja rozszerzona służy do dokładniejszej analizy sytuacji.

Najlepiej sprawdza się:

- przy powtarzających się trudnościach,
- podczas planowania wsparcia,
- w pracy zespołowej,
- przy budowaniu hipotez funkcjonalnych.

Pozwala oddzielić:

- obciążenia z całego dnia,
- bezpośredni wyzwalacz,
- wymagania i przewidywalność,
- pierwsze sygnały,
- działania otoczenia,
- przebieg sytuacji,
- czas powrotu do regulacji i gotowości.

Sekcje formularza

Sekcja	Co opisuje	Po co jest
0. Kontekst dnia	Sen, zmęczenie, ból, wcześniejsze obciążenia.	Pomaga ocenić punkt startowy sytuacji.
1. Bezpośrednio przed	Ostatnie minuty przed wzrostem napięcia.	Pozwala oddzielić wyzwalacz od wcześniejszego tła.
2. Wymagania i kontrola	Co było jasne, co narzucone, na co osoba miała wpływ.	Pomaga ocenić rolę przewidywalności i autonomii.
3. Pierwsze sygnały	Zmiany zachowania przed eskalacją.	Pomaga zauważyć moment na wcześniejsze wsparcie.
3B. Maskowanie i kompensacja	Czy osoba działała mimo przeciążenia.	Pokazuje koszt utrzymywania „pozornego funkcjonowania”.
4. Działania otoczenia	Rodzaj wsparcia i reakcję środowiska.	Pozwala sprawdzić, co pomagało, a co zwiększało trudność.
5. Zachowanie	Fakty obserwowalne.	Oddziela opis od interpretacji.
6. Powrót do gotowości	Czas i warunki potrzebne do odzyskania kontaktu.	Pomaga planować dalszą aktywność.
7. Co było później	Dalszy przebieg sytuacji.	Pozwala ocenić ryzyko wtórnej eskalacji.

Jak używać danych z formularzy

Formularz ma sens przede wszystkim wtedy, gdy porównujemy kilka sytuacji.

Jedno zdarzenie pokazuje pojedynczy dzień. Kilka formularzy pozwala zauważyć wzorzec.

Na co zwracać uwagę

- Czy trudności pojawiają się częściej o konkretnej porze dnia?
- Czy wzrost napięcia pojawia się po zmianach planu?
- Czy określony typ wymagań zwiększa trudność?
- Czy osoba potrzebuje długiego czasu na powrót do gotowości?
- Czy konkretne warunki środowiskowe zwiększają obciążenie?
- Czy wsparcie było dostępne wystarczająco wcześniej?

Czego formularz nie zakłada

Formularz nie zakłada, że:

- każde wymaganie jest szkodliwe,
- każda trudność wynika wyłącznie z sensoryki,
- wsparcie oznacza brak granic,
- analiza kontekstu wyklucza odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Celem formularza nie jest usuwanie wszystkich wymagań.

Celem jest:

- lepsze rozumienie sytuacji,
- wcześniejsze zauważanie sygnałów,
- dostosowanie sposobu wsparcia,
- zmniejszanie niepotrzebnego przeciążenia,
- budowanie bardziej przewidywalnego środowiska.

Celem nie jest usunięcie wszystkich wymagań.

Celem jest sprawdzanie:

kiedy,

jak

i w jakich warunkach

stają się dostępne.

Czego formularz nie robi

Nie diagnozuje

Formularz nie diagnozuje autyzmu, ADHD, PDA, traumy ani innych trudności rozwojowych lub psychicznych.

Może dostarczać materiału obserwacyjnego pomocnego w dalszej ocenie, ale sam nie jest narzędziem diagnostycznym.

Nie służy do oceniania

Formularz nie służy do:

- przypisywania złej woli,
- oceniania charakteru,
- budowania narracji o „trudnym dziecku”,
- uzasadniania kar.

Nie zastępuje oceny klinicznej

Formularz nie zastępuje:

- diagnozy,
- funkcjonalnej oceny zachowania,
- planu wsparcia,
- supervizji klinicznej.

Jest narzędziem do zbierania danych i budowania hipotez.

Nie daje jednej odpowiedzi

Nie każdy wzorec będzie od razu widoczny.

Czasem potrzeba kilku lub kilkunastu zapisów, żeby zauważyć:

- powtarzalne obciążenia,
- konkretne warunki,
- skuteczne strategie wsparcia.

Formularz ma pomagać w myśleniu o sytuacji,
nie zamykać jej w jednej interpretacji.

Podstawa merytoryczna

Formularz opiera się między innymi na:

- analizie funkcjonalnej zachowania,
- obserwacji kontekstu środowiskowego,
- podejściach trauma-informed,
- wiedzy dotyczącej regulacji, interocepcji i sensoryki,
- badaniach dotyczących autonomii i przewidywalności.

Najważniejsze źródła:

- Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2020). *Applied Behavior Analysis* (3rd ed.). Pearson.
- Allen et al. (2024). Neurodiversity-Affirming Applied Behavior Analysis. *Behavior Analysis in Practice*.
- Mathur, S. K., Renz, E., & Tarbox, J. (2024). Affirming Neurodiversity within Applied Behavior Analysis. *Behavior Analysis in Practice*.
- O'Neill, R. E., Albin, R. W., Storey, K., Horner, R. H., & Sprague, J. R. (2015). *Functional Assessment and Program Development for Problem Behavior: A Practical Handbook* (3rd ed.). Cengage Learning.
- Garfinkel, S. N., Seth, A. K., Barrett, A. B., Suzuki, K., & Critchley, H. D. (2015). Knowing your own heart: Distinguishing interoceptive accuracy from interoceptive sensibility. *Biological Psychology*, 104, 65–74.
- Shah, P., Hall, R., Catmur, C., & Bird, G. (2016). Alexithymia, not autism, is associated with impaired interoception. *Cortex*, 81, 215–220.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The „what” and „why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- O’Nions, E., Christie, P., Gould, J., Viding, E., & Happé, F. (2014). Development of the „Extreme Demand Avoidance Questionnaire” (EDA-Q): Preliminary observations on a trait measure for pathological demand avoidance. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(7), 758–768.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2014). *SAMHSA’s Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach*. HHS Publication No. SMA 14-4884.

Małgorzata Mikołajczyk

Psycholog · Analitik zachowania (BCBA)

<http://autyzm.poznan.pl>